PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO PRÉ-CLÍNICO

Cuidar o presente, preparar o futuro

Programa de acompanhamento para portadores assintomáticos de mutações no gene da proteína do prião

Ter informação sobre a sua genética é um ato de coragem. Este website foi criado para o/a acompanhar: explicar o que significa ser portador ou portadora, por que o acompanhamento regular é uma ferramenta poderosa, e que oportunidades o futuro próximo traz

01

Compreender o seu ponto de partida

O que significa ser portador ou portadora

É portador ou portadora de uma variante genética (também chamada mutação, uma alteração no ADN em relação à maioria da população) que pode estar associada ao desenvolvimento de uma doença priónica hereditária. Isto significa que existe um risco aumentado, não uma certeza. Muitas pessoas com esta condição genética vivem décadas sem desenvolver qualquer sintoma, e a ciência avança de forma acelerada para tratamentos preventivos.

> *Ser portador ou portadora não é o mesmo que ter a doença. É uma condição que lhe dá informação valiosa — e essa informação, bem utilizada, pode tornar-se numa vantagem real.*

- **Nem todos os portadores e portadoras desenvolvem sintomas.** A penetrância —ou seja, a probabilidade de que a mutação acabe por causar a doença— é alta, embora a idade de início varie consideravelmente consoante a mutação específica e outros fatores individuais que ainda desconhecemos.

- **O conhecimento é poder.** Conhecer o seu estado genético permite-lhe tomar decisões informadas, planear o futuro e aceder a programas de acompanhamento especializados.

- **A ciência não para.** Nunca houve tanta investigação ativa em doenças priónicas como agora. Estamos num momento decisivo para o desenvolvimento de terapias preventivas.

02

Por que o acompanhamento importa

Quatro razões para fazer parte de um programa de acompanhamento pré-clínico

Os programas de acompanhamento para portadores assintomáticos não são apenas uma ferramenta de investigação e vigilância médica. São uma plataforma de preparação ativa — para si e para todas as pessoas que virão – face às terapias preventivas em desenvolvimento.

Deteção precoce

Deteção precoce: Se ocorressem alterações biológicas subtis, seriam identificadas no momento mais oportuno (antes do aparecimento de sintomas) para intervir com as ferramentas disponíveis.

Acesso prioritário

Acesso prioritário: Os participantes em programas de acompanhamento seriam os sujeitos mais bem posicionados para aceder a novas terapias preventivas quando os ensaios clínicos abrem as suas portas, dado que se disporia de mais informação do que sobre outros portadores.

Informação real

O acompanhamento regular fornece dados objetivos sobre a sua saúde cerebral, substituindo a incerteza por conhecimento fundamentado. É uma informação à qual pode aceder ou decidir ainda não conhecer.

Contribuição coletiva

A sua participação ajuda a compreender melhor a doença e acelera o desenvolvimento de tratamentos para si e para as gerações futuras.

03

Duas realidades dentro do mesmo perfil

Nem todos os portadores assintomáticos estão no mesmo momento

Dentro do grupo de portadores assintomáticos, a investigação atual permite identificar duas situações claramente distintas, embora em ambas a pessoa se encontre sem sintomas clínicos:

Portador/a em fase inativa

O processo biológico associado à mutação não mostra sinais de atividade detetável com as técnicas atuais. Isto associa-se a um horizonte temporal mais amplo antes de poderem aparecer os primeiros sintomas.

Portador/a em fase ativa silenciosa

Existe uma atividade biológica incipiente —sem sintomas clínicos— que as técnicas especializadas podem começar a detetar. Este perfil associa-se a um horizonte temporal mais próximo, embora ainda desconheçamos quanto e se há muita variabilidade entre portadores desde a deteção de atividade biológica até ao desenvolvimento dos primeiros sinais. No entanto, é o grupo que com maior probabilidade poderá aceder aos primeiros ensaios clínicos preventivos.

Saber em que situação se encontra é voluntário. O programa de acompanhamento oferecer-lhe-á a possibilidade de o saber, sempre com apoio e sem pressão.

04

O que está para vir

Terapias em desenvolvimento e ensaios clínicos

Nunca houve tantas estratégias terapêuticas ativas ao mesmo tempo em doenças priónicas. Várias já mostraram resultados promissores em modelos animais, e algumas começaram a dar o salto para ensaios em pessoas. Isto não garante que todas funcionem em humanos, mas marca uma mudança histórica: pela primeira vez existem várias vias reais a avançar em paralelo para futuros tratamentos preventivos e modificadores da doença.

O QUE SIGNIFICA CADA SITUAÇÃO

Ensaio clínico em curso

Já está a ser testado em pessoas.

Ensaio clínico registado, pendente de início

O estudo já está definido e autorizado/registado, mas ainda não começou a recrutar nem a administrar o tratamento.

Desenvolvimento pré-clínico

A terapia mostrou atividade em laboratório e/ou em animais, mas ainda não foi testada em pessoas.

Ensaio clínico em curso (fase 1/2a)

Oligonucleótidos antissentido (ASOs)

São moléculas concebidas para reduzir a produção da proteína do prião. Em modelos animais, diminuir esta proteína atrasou o início da doença e prolongou a sobrevivência. Esta estratégia já está a ser avaliada em pessoas com doença priónica sintomática num ensaio clínico internacional.

Ensaio clínico registado, pendente de início (fase 1)

ARN de interferência (siRNA)

Estas moléculas «silenciam» a mensagem genética que dá origem à proteína do prião. Em animais conseguiram reduções profundas e duradouras desta proteína, com efeitos benéficos sobre a evolução da doença. Além disso, já existe um primeiro ensaio clínico de fase 1 registado para esta estratégia, embora o recrutamento ainda não tenha começado.

Desenvolvimento pré-clínico

Pequenas moléculas para administração oral

Estão a ser desenvolvidos compostos capazes de reduzir a quantidade de proteína do prião que a célula consegue produzir. A sua grande vantagem potencial é que poderiam ser administrados como tratamentos simples e prolongados. Os dados públicos comunicados até ao momento mostram resultados promissores em animais, mas esta via ainda não avançou para ensaios clínicos.

Desenvolvimento pré-clínico

Terapias génicas

Incluem estratégias de silenciamento duradouro e de edição molecular orientadas para desativar ou reduzir de forma estável o gene da proteína do prião. Em modelos animais já alcançaram uma ampla redução da proteína e uma prolongação significativa da sobrevivência. Alguns programas estão a avançar para a clínica, mas por agora mantêm-se em fase pré-clínica.

Estar inscrito num programa de acompanhamento coloca-o/a na linha da frente para aceder a estes ensaios, caso sejam realizados em Espanha. A janela de oportunidade está a abrir-se — e quem já está em acompanhamento terá maiores probabilidades de ser dos primeiros a atravessá-la.

05

O que inclui o acompanhamento

O protocolo de visitas periódicas

O programa consiste em visitas periódicas — geralmente anuais ou bianuais — num centro especializado. Cada visita está concebida para ser o mais confortável e eficiente possível, sempre com o apoio de uma equipa dedicada.

Avaliação neurológica e neuropsicológica

Exploração clínica detalhada e bateria de testes cognitivos para estabelecer e monitorizar a sua linha de base individual.

Biomarcadores no sangue, líquido cefalorraquidiano e pele

Análise de sangue e, quando indicado, punção lombar e/ou microbiopsia de pele para medir proteínas específicas que refletem o estado neurobiológico.

Estudo do sono

Mediante polissonografia, registamos o que acontece durante o sono: movimentos, respiração, atividade cerebral e comportamento. Algumas alterações do sono – em particular as relacionadas com a fase REM – podem aparecer especialmente em portadores de Insónia Familiar Fatal, de forma subtil antes de surgirem os primeiros sintomas.

Imagens de alta resolução

Ressonância magnética do cérebro que permite detetar alterações estruturais ou funcionais antes de serem clinicamente evidentes.

Apoio psicológico

Acompanhamento emocional e orientação especializada, disponível em cada visita e acessível entre visitas quando necessário.

Informação sobre as novidades em terapia

Atualização periódica sobre os ensaios clínicos disponíveis ou em preparação para os quais poderia ser elegível, com orientação personalizada para cada oportunidade.